

Terapia familiar experiencial

A terapia familiar como um encontro emocional

Da ala humanística da psicologia surgiu um ramo experiencial de terapia familiar que, como as terapias expressivas que o inspiraram, enfatizava a **experiência do aqui e agora**, imediata. A terapia experiencial foi mais popular quando a terapia familiar era jovem, quando os terapeutas falavam sobre sistemas, mas tomavam emprestadas suas técnicas das terapias individual e de grupo. Da terapia da Gestalt e dos grupos de encontro vieram técnicas evocativas como o *desempenho de papel* e a *confrontação emocional*, enquanto outros métodos expressivos, como a *escultura* e o *deseño da família*, traziam a influência das artes e do psicodrama.

Ao focar mais a experiência emocional do que a dinâmica da interação, os terapeutas experienciais pareciam estar em descompasso com o restante da terapia familiar. Na verdade, ao enfatizar os indivíduos e seus sentimentos, o tratamento experiencial talvez nunca tenha sido tão adequado à terapia familiar quanto as abordagens que lidavam com sistemas e ação. Com a morte dos líderes que inspiraram esta tradição, Virginia Satir e Carl Whitaker, os métodos popularizados por eles começaram a parecer um tanto obsoletos, mais um produto da década de 1960 do que do mundo de hoje.

Recentemente, contudo, as abordagens experienciais entraram em voga novamente e, como veremos, dois dos modelos mais novos, a terapia de casal com foco emocional de Greenberg e Johnson (1985) e o modelo sistê-

mico familiar interno (1995), combinaram o impacto emocional de um foco experiencial no indivíduo com um entendimento mais sofisticado do sistema familiar.

Conforme o primeiro grande terapeuta catártico – Sigmund Freud – descobriu, entrar em contato com sentimentos dolorosos não é, por si só, um modelo suficiente de psicoterapia. Por outro lado, ignorar ou racionalizar emoções infelizes pode negar aos clientes a oportunidade de chegar ao âmago de seus problemas. Assim, a ênfase experiencial na expressão emocional continua um contrapeso útil à ênfase reducionista no comportamento e na cognição, tão comum nas abordagens atuais à solução de problemas.

ESBOÇO DE FIGURAS ORIENTADORAS

Dois gigantes se destacam no desenvolvimento da terapia familiar experiencial: Carl Whitaker e Virginia Satir. Whitaker foi o maior expoente de uma abordagem intuitiva, livre e improvisada, que tinha como objetivo desfazer falsas aparências e liberar os membros da família para serem eles mesmos. Ele estava entre os primeiros a fazer psicoterapia com famílias e, embora tenha sido em certo momento considerado uma espécie de rebelde indisciplinado, acabou se tornando um dos terapeutas mais admirados no campo. Iconoclasta, às vezes até excêntrico, Whitaker granjeou o respeito do campo da terapia familiar. Talvez ele fosse o seu *enfant terrible*, mas era um deles.

Whitaker cresceu em uma fazenda de gado leiteiro no estado de Nova York. O isolamento rural produziu uma certa timidez, mas



Carl Whitaker utilizou uma abordagem intuitiva e livre para despertar os membros da família para seus anseios internos.

também o condicionou a ser menos limitado pelas convenções sociais. Após concluir o curso de medicina e a residência em obstetrícia e ginecologia, Whitaker foi para a psiquiatria e ficou fascinado pela mente psicótica. Infelizmente – ou felizmente –, na década de 1940 Whitaker não podia recorrer a drogas neurolépticas para mitigar as imagens alucinatórias de seus pacientes; em vez disso, ele escutava e aprendia a compreender pensamentos loucos, mas humanos, pensamentos que a maioria de nós habitualmente mantém enterrados.

Depois de trabalhar no University of Louisville College of Medicine e no Oakridge Hospital, Whitaker aceitou a chefia do Departamento de Psiquiatria da Emory University, onde permaneceu de 1946 a 1955, quando, diante da crescente pressão para tornar o departamento mais psicanalítico, Whitaker e todo o seu corpo docente, incluindo Thomas Malone, John Warkentin e Richard Felder, demitiram-se para criar a Atlanta Psychiatric Clinic. A psicoterapia experiencial nasceu dessa união, e o grupo produziu alguns artigos provocativos e desafiadores (Whitaker e Malone, 1953). Em 1965, Whitaker transferiu-se para a University of Wisconsin Medical School. Após sua aposentadoria no final da década de 1980, viajou muito para compartilhar sua sabedoria e experiência em congressos e oficinas. Sua morte, em 1995, foi uma grande perda. Entre seus colegas mais conhecidos estão Augustus Napier, agora em prática privada em Atlanta, e David Keith, na State University of New York, em Siracusa.

A outra figura proeminente entre os terapeutas familiares experienciais foi Virginia Satir. Um dos primeiros membros do Mental Re-

search Institute (MRI), Satir enfatizava a comunicação (veja Capítulos 3 e 6) e a experiência emocional.

Satir começou a atender famílias em prática privada em Chicago, em 1951. Em 1955, ela foi convidada a montar um programa de formação para residentes no Illinois State Psychiatric Institute (onde um de seus alunos foi Ivan Boszormenyi-Nagy). Em 1959, Don Johnson convidou-a a se reunir a ele no MRI, onde Satir tornou-se a primeira diretora de treinamento e permaneceu até 1966, quando partiu para ser diretora do Esalen Institute em Big Sur, Califórnia.

Satir era a terapeuta nutridora arquetípica em um campo enamorado por conceitos abstratos e manobras estratégicas. Sua cordialidade e honestidade tornavam-na imensamente atraente quando viajava pelo país fazendo demonstrações e oficinas. Sua capacidade de encantar o público a tornou a humanista mais celebrada da terapia familiar. Satir morreu de câncer pancreático em 1988.

Entre as abordagens experienciais mais recentes está a terapia de casal de Leslie Greenberg e Susan Johnson, com foco na emoção, que utiliza elementos do trabalho de Perls, Satir e do grupo do MRI (Greenberg e Johnson, 1985, 1986, 1988). Outra abordagem especializada à vida emocional interior das famílias é a terapia sistêmica familiar interna de Richard Schwartz (1995), em que as vozes internas conflituosas dos clientes são personificadas como “partes” e depois reintegradas, com o uso de técnicas psicodramáticas variadas. Schwartz vive em Chicago, onde tem uma clínica e um programa de formação.

FORMULAÇÕES TEÓRICAS

A terapia familiar experiencial baseia-se na premissa de que a causa fundamental dos problemas familiares é a supressão emocional. Embora as crianças precisem aprender que nem sempre podem fazer o que querem, muitos pais têm a tendência infeliz de confundir as funções *instrumental* e *expressiva* da emoção. Tentam regular as ações dos filhos controlando seus sentimentos. Como resultado, as crianças aprendem a amenizar sua experiência emocional para evitar provocação. Embora esse pro-

cesso seja mais ou menos universal, as famílias disfuncionais tendem a tolerar menos do que a maioria as emoções que sinalizam individualidade. Como resultado, os filhos dessas famílias geralmente crescem apartados de si mesmos e sentindo apenas os resíduos do afeto reprimido: aborrecimento, apatia e ansiedade.

Enquanto os terapeutas sistêmicos vêem as raízes do comportamento sintomático na dança das interações familiares, os experientialistas vêem essas interações como o resultado de uma dança superficial dos membros da família com as projeções das defesas dos outros. Dessa perspectiva, tentativas de provocar mudanças positivas nas famílias terão maior probabilidade de sucesso se os membros da família entrarem em contato, em primeiro lugar, com seus reais sentimentos – suas esperanças e seus desejos, assim como seus medos e suas ansiedades. Portanto, a terapia familiar experiential trabalha de dentro para fora – ajudando os indivíduos a descobrirem suas emoções verdadeiras e depois forjando laços familiares mais genuínos a partir dessa autenticidade aumentada.



Carl Whitaker resumiu a posição experiential em relação à teoria em um artigo intitulado *The hindrance of theory in clinical work* (Whitaker, 1976a). A teoria pode ser útil para os iniciantes, disse Whitaker, mas seu conselho era que abandonássemos os cálculos assim que possível, em favor de sermos apenas nós mesmos.

Ser antiteórico, evidentemente, é em si uma posição teórica. Dizer que uma terapia não deve ser limitada por teorias é dizer que ela deve ser criativa e espontânea. Apesar do desprezo de Whitaker pela teoria, a terapia familiar experiential é em grande parte um produto da tradição existencial-humanista.

Muito da teorização dos psicólogos existenciais (por exemplo, Binswanger, 1967; Boss, 1963) foi em reação às deficiências percebidas na psicanálise e no comportamentalismo. Em lugar do *determinismo*, os existencialistas enfatizavam a liberdade e a imediação da experiência. Onde os psicanalistas postulavam um modelo estruturalizado da mente, os existencialistas tratavam as pessoas como um todo e ofe-

reciam um modelo positivo de humanidade, em lugar do que viam como um modelo psicanalítico pessimista. Em vez de buscar a resolução de suas neuroses, os existencialistas acreditavam que as pessoas deveriam buscar a realização.

Apesar da relutância em teorizar, há certas premissas básicas que definem a posição experiential. Whitaker enfatizava que a auto-realização depende da coesão familiar, e Satir destacava a importância da boa comunicação entre os membros da família, mas o compromisso fundamental era com a *auto-expressão individual*. Embora houvesse alguma discussão sobre sistema familiar (por exemplo, Satir, 1972), o modelo experiential das famílias era mais como um grupo democrático do que como uma organização estruturada. É dada muita ênfase à *flexibilidade* e à *liberdade*. O tratamento visa a ajudar os membros da família a encontrar papéis que os realizem, com menor preocupação com a família como um todo. Isso não significa que as necessidades da família sejam descartadas, e sim que se supõe que seguem de perto a melhora individual.¹

Depois de ler o parágrafo anterior, David Keith (em uma carta pessoal) ajudou a colocar em perspectiva a posição experiential em relação às reivindicações do indivíduo *versus* as reivindicações da família:

Existe uma tensão dialética entre o indivíduo e a família – entre dependência e independência. Enfatizar demais ou a individualidade ou a conexão familiar é distorcer a condição humana.

As teorias das famílias como sistemas se traduzem em técnicas que promovem comunicação e interação. A ênfase na alteração das interações implica uma aceitação de qualquer nível de experiência individual que já esteja presente. É nisto que a teoria experiential difere da maioria das abordagens sistêmicas. Aqui a ênfase está em expandir a experiência. A suposição é que abrir os indivíduos para a sua experiência é o pré-requisito para abrir novas possibilidades ao grupo familiar.

A premissa subjacente da terapia familiar experiential é que a maneira de promover o crescimento individual e a coesão familiar consiste em liberar afetos e impulsos. Os esforços

para reduzir a defensividade e descerrar níveis mais profundos de experiência baseiam-se na suposição da bondade básica da natureza humana.

A exceção à pouca ênfase experiencial na teoria é a terapia de casal de Greenberg e Johnson, focada na emoção, que utiliza elementos da teoria do apego (Bowlby, 1969). Segundo Greenberg e Johnson, a emoção organiza as respostas de apego e tem uma função comunicativa nos relacionamentos. Quando as pessoas expressam sua vulnerabilidade diretamente, é provável que eliciem uma resposta compassiva nos parceiros. Contudo, quando uma pessoa com apego inseguro teme a vulnerabilidade e demonstra raiva em vez de vulnerabilidade, a resposta provavelmente será afastamento. Assim, a pessoa que mais precisa de apego pode, por temer expor essa necessidade, empurrar para longe as pessoas amadas de quem quer se aproximar. O antídoto para este dilema é o que a terapia experiencial significa: ajudar as pessoas a afrouxar medos defensivos para que emoções mais profundas e genuínas possam emergir.

A redescoberta da teoria do apego contribui com o esforço maior para reivindicar a dependência como uma tendência humana natural. Nos termos de Bowlby (1969), o apego fornece à pessoa uma base segura – a capacidade de regular emoções e a confiança para explorar o mundo. Quando o apego é ameaçado, a primeira resposta provavelmente será a raiva e o protesto, seguidos por alguma forma de aderência, que eventualmente dá lugar ao desespero. Por fim, se as figuras de apego não respondem, ocorrem o desligamento e a separação (Bowlby, 1969).

Embora o apego tenha suas bases nos primeiros anos da infância, Bowlby (1988) acreditava que toda interação significativa com os outros continua moldando crenças sobre a disponibilidade e a sustentação das pessoas. Embora a segurança do apego possa ser em grande parte global, as pessoas também desenvolvem crenças específicas de determinados relacionamentos, baseadas nas experiências com um determinado parceiro (Collins e Read, 1994). O processo, evidentemente, é circular. Quanto mais segura e confiante for a pessoa, mais provável que seja aberta a – e nos – relacionamentos; assim, maior é a probabilidade

de que ela desenvolva relacionamentos que confirmem seu senso de valor na relação. O inverso, infelizmente, também é verdade: as pessoas que têm medo de expressar suas necessidades de apego podem permanecer aprisionadas a padrões negativos que impedem a responsividade necessária à construção de relacionamentos seguros.

Ainda precisa se demonstrar que os padrões de apego da infância continuam a desempenhar um papel central nos relacionamentos adultos íntimos (veja Capítulo 4). Todavia, como na maioria das hipóteses clínicas, o valor da teoria do apego na prática da terapia está mais em sua utilidade do que em sua confirmação empírica.

DESENVOLVIMENTO FAMILIAR NORMAL

Os terapeutas experienciais aderem à fé humanista na sabedoria natural das emoções honestas. Deixadas livres, as pessoas tendem a florescer, segundo este ponto de vista. Os problemas surgem porque esta tendência inata para a *auto-realização* (Rogers, 1951) entra em choque com pressões sociais. A sociedade impõe a repressão para domar os instintos das pessoas e adequá-los à vida em grupo. Infelizmente, o autocontrole é obtido à custa da “repressão excedente” (Marcuse, 1955). As famílias acrescentam seus próprios controles para obter paz e tranquilidade, perpetuando **mitos familiares** obsoletos (Gehrke e Kirschenbaum, 1967) e utilizando a **mistificação** (Laing, 1967) para alienar as crianças das suas experiências.

Na situação ideal, o controle parental não é excessivo, e os filhos crescem em uma atmosfera que apóia seus sentimentos e impulsos criativos. Os pais escutam os filhos, aceitam seus sentimentos e validam sua experiência. O afeto é valorizado e nutrido; as crianças são incentivadas a experienciar a vida integralmente e a expressar toda a variedade das emoções humanas.

Os terapeutas experienciais descrevem a família como o lugar para compartilhar experiências (Satir, 1972). As famílias funcionais são suficientemente seguras para apoiar e encorajar uma grande variedade de experiências; as famílias disfuncionais são temerosas e cruéis.

Nenhuma habilidade de solução de problemas e nenhuma estrutura familiar específica são consideradas tão importantes quanto nutrir um experienciar aberto, natural e espontâneo. Em resumo, a família sadia oferece aos seus membros a liberdade de serem eles mesmos.

DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO

De uma perspectiva experiencial, a negação dos impulsos e a supressão dos sentimentos são as raízes dos problemas familiares. As famílias disfuncionais estão aprisionadas na autoproteção e na evitação (Kaplan e Kaplan, 1978). Nos termos de Harry Stack Sullivan (1953), elas buscam *segurança* em vez de *satisfação*. Suas queixas são variadas, mas o problema básico é que elas escondem emoções e desejos.

Segundo Whitaker (Whitaker e Keith, 1981), casamento é algo que não existe – o que existe são dois bodes expiatórios enviados por suas famílias para se perpetuarem. Juntos, precisam encontrar uma solução para o conflito inerente a essa situação. Os casais que permanecem juntos acabam atingindo algum tipo de acomodação. Com base em concessões mútuas ou resignação, a harmonização entre os parceiros diminui os atritos prévios. As famílias disfuncionais, com um medo terrível de conflitos, aderem rigidamente aos rituais que desenvolveram juntos. Tendo experienciado a ansiedade da incerteza, agora se agarram às suas rotinas.

Em sua descrição das famílias perturbadas, Satir (1972) enfatizou a atmosfera de morte emocional. Essas famílias são frias; parecem continuar unidas por hábito ou dever. Os adultos não se divertem com os filhos, e as crianças aprendem a não se valorizar ou a se importar com os pais. Em consequência da falta de calor na família, essas pessoas se evitam mutuamente e se preocupam com o trabalho e com outras distrações.

É importante notar que a “disfunção” descrita por Satir não é do tipo encontrado em manuais diagnósticos. Como outros no campo experiencial, Satir estava tão interessada nas pessoas “normais” que vivem em silencioso desespero quanto nos pacientes oficialmente

reconhecidos nos quais as famílias habitualmente se concentram. Conforme ela coloca,

Para mim, é uma experiência triste estar com essas famílias. Vejo a desesperança, a impotência, a solidão. Vejo a bravura de pessoas tentando encobrir isso – uma bravura que ainda urra, censura ou se lamenta para os outros. Os outros já não se importam. Essas pessoas seguem, ano após ano, suportando a miséria elas próprias ou, em seu desespero, infligindo-a aos outros. (Satir, 1972, p. 12)

Satir enfatizou o papel da comunicação destrutiva na asfixia dos sentimentos e disse que havia quatro maneiras desonestas de comunicação entre as pessoas: *culpar*, *aplar*, *ser impertinente* e *ser muito razoável*. O que está por trás desses padrões de comunicação inautêntica? *Baixa auto-estima*. Se as pessoas se sentem mal consigo mesmas, é difícil falar a verdade sobre seus sentimentos – e ameaçador deixar que os outros lhes digam honestamente o que sentem.

OBJETIVOS DA TERAPIA

Na terapia familiar experiencial, o alívio dos sintomas é secundário ao aumento da integridade pessoal e à expansão das experiências (Malone, Whitaker, Warkentin e Felder, 1961). Os problemas apresentados pelas famílias são considerados tíquetes de admissão (Whitaker e Keith, 1981); o problema real é a esterilidade emocional.

A maioria dos terapeutas experienciais focaliza os indivíduos e sua experiência mais do que a organização familiar. No caso de Kempler (1981, p. 27), o compromisso com o indivíduo é reconhecido: “Considero que a minha responsabilidade primeira é para com as pessoas – com cada indivíduo dentro da família – e, secundariamente, para com a organização chamada família”. Esta ênfase no indivíduo acima da família *não* existe nos terapeutas familiares experienciais com inclinação mais sistêmica, como Carl Whitaker, David Keith e Gus Napier.

Em comum com outros na tradição existencial-humanista, os terapeutas experienciais acreditam que o caminho para a saúde emocional é descobrir níveis mais profundos de expe-

riência. Virginia Satir (1972, p. 120) colocou da seguinte maneira:

Tentamos operar três mudanças no sistema familiar. Primeiro, cada membro da família deveria ser capaz de relatar congruente, completa e honestamente o que vê e escuta, sente e pensa, sobre si mesmo e os outros, na presença de outros. Segundo, cada pessoa deveria ser tratada e considerada no relacionamento em termos de sua singularidade, de modo que as decisões sejam tomadas em termos de exploração e negociação, e não em termos de poder. Terceiro, a diferença entre as pessoas deveria ser abertamente reconhecida e utilizada para o crescimento.

Quando os métodos experienciais são aplicados ao sistema familiar (e não a indivíduos que por acaso estão reunidos em grupos familiares), o objetivo de crescimento individual se funde ao objetivo de fortalecer a unidade familiar. O trabalho de Carl Whitaker corporificou maravilhosamente esse duplo objetivo. Segundo ele, o crescimento pessoal requer integração familiar, e vice-versa. O pertencimento e a individuação se acompanham.

Os experientialistas enfatizam o sentimento da natureza humana: criatividade, espontaneidade e capacidade de brincar – e, na terapia, o valor da experiência em si.

Acredita-se que novas experiências rompem expectativas rígidas e destravam a consciência dos membros da família – e tudo isso promove individuação (Kaplan e Kaplan, 1978). Bunny e Fred Duhl (1981) falam de seus objetivos como maior senso de competência, bem-estar e auto-estima. Ao enfatizar a auto-estima, os Duhl ecoam Virginia Satir (1964), que acreditava que a baixa auto-estima e a comunicação destrutiva responsável por ela eram os principais problemas nas famílias infelizes. Whitaker (1976a) acreditava que as famílias procuram tratamento por não conseguirem proximidade e por serem incapazes, portanto, de se individuar. Ao ajudar os membros da família a recuperarem seu potencial de experimentar, ele acreditava que também os estava ajudando a recuperarem a capacidade de se importarem uns com os outros.

CONDIÇÕES PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Entre as concepções errôneas dos mais inexperientes em terapia familiar está a de que as famílias são frágeis e os terapeutas devem ter cuidado para que não quebrem. Um mínimo de experiência nos ensina o oposto: o tratamento efetivo requer intervenções efetivas – e, para o terapeuta familiar experiencial, este poder vem do experimentar emocional.

O terapeuta experiencial utiliza técnicas evocativas e a força de sua personalidade para criar encontros terapêuticos. A vitalidade do terapeuta como pessoa é uma força maior na terapia; a vitalidade do *encontro* é outra. Acredita-se que essa experiência poderosamente pessoal ajuda a estabelecer relacionamentos interessados, de pessoa a pessoa, entre todos os membros da família. Gus Napier (Napier e Whitaker, 1978) apresenta, em *The family crucible*, uma excelente descrição do que causa a mudança na opinião dos terapeutas experienciais. As descobertas e os avanços acontecem quando os membros da família se arriscam a ser “mais separados, divergentes, até mais zangados” e também “quando se arriscam a ser mais próximos e mais íntimos”. Para ajudar os clientes a assumirem esses riscos, os terapeutas experienciais são provocativos e também apoiadores. Isso permite aos membros da família abandonarem defesas protetoras e abrirem-se uns para os outros.

Acredita-se que o *encontro existencial* é a força essencial no processo psicoterapêutico (Kempler, 1973; Whitaker, 1976a). Esses encontros precisam ser recíprocos; em vez de se esconder por trás de um papel profissional, o terapeuta precisa ser uma pessoa genuína, que catalisa a mudança, utilizando seu impacto pessoal nas famílias. Conforme Kempler (1968, p. 97) afirmou:

Nesta abordagem, o terapeuta torna-se um membro da família durante as entrevistas, participando tão inteiramente quanto for capaz, confiantemente disponível para apreciação e críticas, e também capaz de dispensá-las. Ele ri, chora e se enfurece. Ele sente e compartilha sua vergonha, confusão e impotência.

Para Satir, interesse e aceitação eram o segredo para ajudar alguém a se abrir à experiência e aos outros:

Alguns terapeutas acham que as pessoas entram em terapia não querendo ser mudadas: acho que isso não é verdade. Elas não acreditam que *podem* mudar. Entrar em um lugar novo, desconhecido, é algo apavorante. Quando começo a trabalhar com pessoas, não estou interessada em mudá-las. Estou interessada em descobrir seus ritmos, ser capaz de me reunir a elas e ajudá-las a entrar nesses lugares apavorantes. A resistência é, essencialmente, o medo de ir onde você jamais foi. (*apud* Simon, 1989, p. 38-39)

Uma vez que as paixões são um negócio complicado, as famílias infelizes contentam-se em submergi-las; os terapeutas experienciais, não. Terapeutas como Whitaker acreditam que importa ser efetivo, não seguro. Portanto, ele, deliberadamente, visava a desestabilizar as famílias com as quais trabalhava.

A maioria das abordagens tem o objetivo de ajudar os membros da família a falarem uns com os outros sobre o que está em sua mente, mas isso só significa que vão compartilhar o que têm consciência de estarem sentindo. Terão menos segredos entre si, mas continuarão a ter segredos para si mesmos, na forma de necessidades e sentimentos inconscientes. Os terapeutas experienciais, por outro lado, acreditam que aumentar os níveis de experiência de cada membro da família levará a interações familiares mais honestas e íntimas. O seguinte exemplo demonstra este processo de mudança “de dentro para fora”.

Estudo de caso

Após uma sessão inicial de coleta de informações, a família L. discutia o mau comportamento de Tommy, de 10 anos. Por vários minutos, a Sra. L. e a irmã mais jovem de Tommy revezaram-se catalogando todas as “coisas terríveis” que ele fazia em casa. Conforme a discussão continuava, a terapeuta percebeu como o Sr. L. parecia desligado. Embora ele, submissamente, concordasse com as queixas da mulher acenando com a cabeça, parecia mais deprimido do que preocupa-

do. Quando indagado sobre o que o preocupava, falou muito pouco, e a terapeuta ficou com a impressão de que, na verdade, muito pouco o *preocupava* – pelo menos conscientemente. A terapeuta não sabia a razão de sua falta de envolvimento, mas sabia que isso a incomodava, e decidiu se manifestar.

Terapeuta: (Para o Sr. L.) Você está escutando isso? O que está acontecendo com você?

Sr. L.: O quê? (Ele ficou chocado, as pessoas que ele conhecia simplesmente não falavam com ele desse jeito.)

Terapeuta: Eu disse: o que está acontecendo com você? Sua mulher está aqui preocupada e chateada com o Tommy, e você simplesmente fica sentado aí como um dois de paus. Você faz parte desta família tanto quanto aquela lâmpada do canto.

Sr. L.: Você não tem o direito de falar assim comigo (ficando cada vez mais zangado). Eu dou duro por esta família. Quem você acha que põe a comida na mesa? Eu levo dois dias por semana e dirijo um caminhão de entregas por toda a cidade. O dia inteiro eu tenho de ouvir os clientes se queixando disso e daquilo. Então volto para casa e o que recebo? Mais queixas. “Tommy fez isso, Tommy fez aquilo.” Estou cheio disso.

Terapeuta: Diga isso novamente, mais alto.

Sr. L.: Estou cheio disso! Estou cheio disso!!

Este intercâmbio transformou dramaticamente a atmosfera da sessão. De súbito, a razão do desinteresse do Sr. L. ficou muito clara. Ele estava furioso com a mulher por se queixar constantemente de Tommy. Ela, por sua vez, deslocava muito do seu sentimento pelo marido para Tommy, em resultado da indisponibilidade emocional do Sr. L. Nas sessões subseqüentes, conforme o Sr. e a Sra. L. passavam mais tempo falando sobre o seu relacionamento, cada vez se ouvia menos sobre o mau comportamento de Tommy.

Seguindo seu impulso emocional, a terapeuta deste exemplo aumentou a intensidade afetiva na sessão ao confrontar um membro da família. A ansiedade gerada quando ela fez isso foi suficiente para expor um problema oculto. Depois que o problema foi desvendado, não foi necessária muita persuasão para que os membros da família comesçassem a enfrentá-lo.

Embora o leitor possa ficar pouco à vontade com a idéia de um terapeuta confrontar tão agressivamente um membro da família, isso não é incomum na terapia experiencial. O que torna esse movimento menos arriscado do que pode parecer é a presença de outros membros da família. É mais seguro provocar quando a família toda está lá do que no tratamento individual. Como Carl Whitaker (1975) salientou, as famílias aceitarão muito de um terapeuta quando estiverem convencidas de que ele se importa genuinamente com elas.

Embora os terapeutas experienciais enfatizem a expansão da experiência individual como o veículo de mudança terapêutica, agora começam a defender a inclusão de tantos membros da família quanto possível no tratamento. Como experientistas, acreditam na experiência pessoal imediata; como terapeutas familiares, crêem na interconexão da família.

Carl Whitaker (1976b) gostava de ter uma multidão na sala quando fazia terapia. Ele insistia em pelo menos dois encontros com a rede familiar extensa, inclusive pais, filhos, avós e cônjuges divorciados. Convidar esses membros da família ampliada é uma maneira efetiva de ajudá-los a apoiar o tratamento, em vez de se opor a ele ou solapá-lo.

A fim de superar a relutância em participar, Whitaker convidava membros da família ampliada como consultores, “para ajudar o terapeuta”, não como pacientes. Nessas entrevistas, os avós eram solicitados a ajudar, a dar a sua percepção da família (passada e presente) e, às vezes, a falar sobre os problemas em seu próprio casamento (Napier e Whitaker, 1978). Os pais podem começar a ver que os avós são diferentes das imagens que introjetaram 20 anos atrás. Os avós, por sua vez, podem começar a perceber que seus filhos agora são adultos.

TERAPIA

Os terapeutas familiares experienciais compartilham a crença humanista de que as pessoas possuem muitos recursos e, se entregues aos meios que estão ao seu alcance, serão ativas, criativas, amorosas e produtivas (Rogers, 1951). A tarefa da terapia, portanto, é a de

desbloquear defesas e libertar a vitalidade inata das pessoas.

Avaliação

Já que os experientistas estão menos interessados em resolver problemas do que em melhorar o funcionamento familiar, eles prestam uma atenção limitada aos aspectos específicos do problema apresentado. Além disso, como focam os indivíduos e suas experiências, têm pouco interesse em avaliar a estrutura da dinâmica familiar.

A seguinte citação ilustra o desprezo experientista pela avaliação. “Os diagnósticos são a lápide da frustração do terapeuta, e acusações como defensiva, resistente e ganho secundário são as flores colocadas no túmulo dessa insatisfação enterrada” (Kempler, 1973, p. 11). O ponto parece ser que a distância objetiva necessária para a avaliação formal estimula uma atitude de julgamento e isola o terapeuta do contato emocional com a família.

Para a maioria dos experientistas, a avaliação ocorre automaticamente conforme o terapeuta passa a conhecer a família. No processo de desenvolver um relacionamento, o terapeuta aprende com que tipos de pessoas está lidando. Whitaker começava pedindo a cada membro da família que a descrevesse e contasse como funcionava. Desta maneira, ele obtinha um quadro composto dos membros individuais da família e de suas percepções do grupo familiar. Este tipo de investigação é o máximo da formalidade de um terapeuta experiencial avaliando uma família. A vasta maioria do que serve como avaliação nesta abordagem é uma tentativa de decodificar as defesas que surgem no curso de se tentar ajudar os familiares a se abrirem uns aos outros.

Técnicas terapêuticas

Segundo Walter Kempler (1968), na terapia experiencial não existem técnicas, apenas pessoas. Este epigrama resume bem a fé no poder curativo da personalidade do terapeuta. O que importa não é tanto o que o terapeuta faz, e sim a pessoa que ele é.

Para promover a abertura em seus pacientes, o terapeuta precisa, ele próprio, ser aberto. Entretanto, este ponto é, no mínimo, em parte retórico. Independentemente de quem é, o terapeuta também precisa *fazer* algo. Mesmo que não seja planejado, o que ele faz pode ser descrito. Ademais, o terapeuta experiencial tende a fazer muito: ele é extremamente ativo, e alguns (incluindo Kempler) utilizam várias técnicas evocativas.

Alguns empregam meios estruturados, como a *escultura familiar* e a *coreografia* para estimular a intensidade afetiva na terapia; outros, como Virginia Satir e Carl Whitaker, confiam na espontaneidade de apenas serem quem são.

Virginia Satir possuía uma capacidade notável de se comunicar. Como muitos grandes terapeutas, ela era uma personalidade dinâmica que envolvia os clientes ativamente desde o primeiro encontro, mas ela não confiava apenas no seu calor pessoal: trabalhava ativamente para esclarecer a comunicação, fazia as pessoas desistirem de se queixar e começarem a buscar soluções, apoiava a autoestima de cada membro da família, salientava intenções positivas (muito antes de a “conotação positiva” tornar-se um meio estratégico) e demonstrava, pelo exemplo, como ser afetuosa (Satir e Baldwin, 1983). Era uma curadora amorosa, mas enérgica.

Uma das marcas registradas de Satir era o uso do toque. Sua linguagem era a linguagem da ternura. Com frequência começava por fazer um contato físico com as crianças, conforme evidenciado em seu caso *Das Pedras e Flores*. Bob, um alcoolista em recuperação, era



Virginia Satir estava mais interessada em ajudar os membros da família a se conectarem do que nas forças psicológicas e sistêmicas que os mantinham separados.

pai de dois meninos, Aaron (4 anos) e Robbie (2 anos), que haviam sofrido abusos repetidos por parte da mãe – tinham sido empurrados escada abaixo, queimados com cigarro e amarrados embaixo da pia. Na época da entrevista, a mãe estava sob tratamento psiquiátrico e não via os filhos. A nova esposa de Bob, Betty, fora abusada pelo primeiro marido, também um alcoolista. Ela estava grávida e temia que os meninos abusassem do bebê. Os meninos já haviam expressado a violência a que haviam sido expostos – batendo em outras crianças e tentando sufocá-las. Bob e Betty, por sua frustração e medo, reagiam asperamente aos meninos, o que só aumentava a agressividade deles.

Durante toda a sessão, Satir mostrou aos pais como tocar nos filhos ternamente e como segurá-los com firmeza para interromper algum mau comportamento. Quando Bob começou a falar com Aaron à distância, Satir insistiu na proximidade e no toque. Ela sentou Aaron diante do pai e pediu a Bob que segurasse as mãoszinhas do menino e falasse diretamente com ele.

Os seguintes fragmentos da sessão foram tirados de Andreas (1991).

Estudo de caso

Aquelas mãozinhas sabem muitas coisas; elas precisam ser reeducadas. OK. Veja, esses dois pequeninos têm muita energia, como vocês dois também. Vou conversar com o terapeuta de vocês a respeito da necessidade de abrir um espaço para que vocês tenham alguma folga (das crianças), mas usem todas as oportunidades que puderem para ter este tipo de contato físico. O que eu também recomendaria a vocês dois é que sejam muito claros em relação ao que esperam e que você (Bob) aprenda com Betty a prestar atenção (às crianças) mais rapidamente.

Eu gostaria que vocês fossem capazes de transmitir suas mensagens sem um “não faça isto”, sem um “não” – e que a força em seus braços quando vocês os segurarem – não sei se conseguirei ilustrar isso, mas me empreste seu braço por um instante (estendendo a mão para o antebraço de Bob). Deixe-me mostrar a diferença. Pegue o meu braço como se você fosse me agarrar. (Bob agarra o braço dela.) Muito bem. Veja, quando você faz isso, todos os meus músculos começam a ficar tensos, e eu sinto vontade de puxá-lo de volta. (Bob concorda com um gesto de cabeça.) Agora, pegue o meu braço como se você quisesse me proteger. (Bob segura o braço dela.) Muito bem. Eu agora sinto a sua força,

mas não sinto vontade de puxá-lo com força, assim. (Bob diz “sim”.)

O que eu gostaria que vocês fizessem é tocar *um bastante*, tocar muito nessas duas crianças. Quando as coisas começarem (a fugir ao controle), vocês vão até lá – não digam nada – apenas vão até eles e os peguem no colo (demonstrando o abraço protetor nos antebraços de Bob), mas vocês precisam saber, bem lá dentro de vocês, que não os estão puxando (Aaron coloca brevemente as mãos em cima das mãos de Virginia e dos braços de Bob) assim (demonstrando), mas estão segurando com força (passando ambas as mãos sobre o braço de Bob), como se percebessem a diferença. Eu demonstrarei para você (Bob), também. Primeiro, vou agarrar você assim (demonstrando). (Bob diz “sim”.) Você se dá conta de que tem vontade de puxar o braço. Muito bem. Agora, desta vez, o que vou fazer é lhe dar uma força (demonstra segurando seu braço com ambas as mãos; Robbie faz um leve afago na mão de Virginia), mas eu não vou pedir a vocês que revidem. O mais importante é vocês comecem com isso.

(Virginia se volta para Betty e oferece seu antebraço.) OK. Agora eu gostaria de fazer o mesmo com você. Então, segure meu braço com bastante firmeza... (Betty agarra o braço de Virginia, e Aaron também.) Isso, assim, como se você realmente quisesse me dar apoio, mas também um limite. (Aaron estende o braço para tocar na mão de Betty, e Virginia pega a mão livre de Aaron com a sua mão livre.) É um leve aperto, um leve aperto.

Então, da próxima vez que vocês sentirem que alguma coisa está vindo, o que vocês vão fazer é ir lá e fazer contato (Virginia demonstra segurando o antebraço de Aaron) e depois largar suavemente. (Virginia segura as mãos de Aaron e começa a tirá-lo do colo de Betty.) Agora, Aaron, eu gostaria que você ficasse ali um minutinho para que eu possa mostrar uma coisa à sua mãe. (Aaron diz “OK”.) Vamos imaginar que, em um momento em que eu não estou pensando, eu pego você assim (agarrando os braços de Betty subitamente com ambas as mãos). Você percebe o que tem vontade de fazer? (Betty concorda com a cabeça.) Muito bem. Agora eu vou fazer isso de outro jeito. Eu estou transmitindo a você a mesma mensagem (Virginia segura o braço de Betty firmemente com ambas as mãos, olhando diretamente em seus olhos, e começa a se levantar), mas estou fazendo deste jeito. Estou olhando para você e estou transmitindo uma mensagem clara. OK. Agora, neste momento, o seu corpo não vai responder a mim negativamente. Ele vai se sentir parado, mas não negativo. Então eu vou pegar você assim. (Virginia coloca um braço em torno das costas de Betty e o outro embaixo do seu antebraço.) Exatamente assim (Virginia coloca ambos os braços em torno de Betty e a traz para mais perto dela) e agora eu vou abraçar você. Vou segurar você assim por um minutinho.

Após esta sessão, Satir comentou sua técnica:

Havia tantas coisas acontecendo, e o medo era tão grande em relação a essas crianças que, se você criasse uma imagem delas, seria de monstros. Então, uma das coisas que eu queria fazer também era ver se eles tinham a capacidade de responder com um toque, usando a mim mesma para isso, fazendo com que colocassem suas mãos em meu rosto – isso era uma espécie de espelho para a família em si, as pessoas da família –, e então autorizá-los e encorajá-los a fazer isso com os pais. Ver, tocar, isso vem do tipo de ambiente que havia lá no momento, diz coisas que nenhuma palavra é capaz de dizer.

Para incentivar a empatia e aproximar os membros da família, Satir com frequência utilizava o seguinte exercício (adaptado de Satir e Baldwin, 1983):

1. Pense em uma situação difícil com seu filho. Talvez ele ande fazendo algo com o que não sabe lidar ou que o deixa subindo pelas paredes.
2. Passe seu filme dessa situação do seu ponto de vista. Imagine que você vive esta situação com seu filho novamente. Observe como você se sente, o que vê, o que escuta.
3. Reexperiencie esta situação, mas desta vez como seu filho. Visualize toda a situação lenta e detalhadamente, como imagina que seria através dos olhos de seu filho. Permita-se sentir o que seu filho deve estar sentindo. Você percebe algum sentimento que não sabia que seu filho poderia ter? Você percebe algo de que ele poderia precisar ou querer e você não sabia?
4. Reexperiencie a mesma situação, desta vez como observador. Olhe e escute o que está acontecendo e permita-se observar tanto seu filho quanto você mesmo. Você percebe alguma coisa na maneira de vocês reagirem um ao outro? O que vê mais claramente em si mesmo e em seu filho?

Já que preferia um encontro pessoal a uma abordagem calculada, não surpreende que o estilo de Whitaker fosse o mesmo com indivíduos, casais ou grupos (Whitaker, 1958). Ele, assiduamente, evitava orientar decisões de vida real, preferindo, em vez disso, abrir os membros da família para seus sentimentos e se reu-

nir a eles em sua incerteza. Isso pode soar banal, mas é um ponto importante. Na medida em que o terapeuta (ou qualquer outra pessoa, por sinal) está ansioso para mudar as pessoas, é difícil, muito difícil, fazer com que se sintam compreendidas – e ainda mais difícil empatizar realmente com elas.

Uma comparação entre o trabalho inicial (Whitaker, Warkentin e Malone, 1959; Whitaker, 1967) e o trabalho posterior de Whitaker (Napier e Whitaker, 1978) mostra como ele mudou no decorrer dos anos. Whitaker começou agindo deliberadamente de forma exótica. Ele poderia adormecer durante uma sessão e depois contar seus sonhos; lutava corpo a corpo com seus pacientes; falava sobre suas fantasias sexuais. Nos últimos anos, ele já não era tão provocativo. Parece que é isso o que acontece aos terapeutas quando amadurecem: têm menor necessidade de se impor e mais disposição para escutar.

Como o tratamento de Whitaker era tão intenso e pessoal, ele acreditava ser essencial trabalhar junto com outro terapeuta. Ter um co-terapeuta para compartilhar a carga impede que ambos sejam absorvidos pelo campo emocional da família. A terapia familiar tende a ativar os próprios sentimentos do terapeuta em relação a certos tipos de familiares. Uma postura imparcial, analítica, minimiza esses sentimentos; o envolvimento emocional os maximiza.

O problema com a contratransferência é que ela tende a ser inconsciente. É mais provável o terapeuta perceber esses sentimentos depois que a sessão acaba. Mais fácil ainda é observar a contratransferência nos outros. Considere o exemplo do Dr. Fox, um homem casado especializado em terapia individual que, ocasionalmente, atende casais com problemas. Em 75% desses casos, o Dr. Fox incentiva o casal a se divorciar, e seus pacientes seguem seus conselhos em um índice muito elevado. Se o Dr. Fox fosse mais feliz em seu casamento, talvez ele se sentisse menos impelido a guiar seus pacientes para onde ele teme estar indo.

Para minimizar a contratransferência, Whitaker recomendava compartilhar abertamente os sentimentos com a família. Se os sentimentos forem expressos abertamente, é menos provável que sejam atuados. Todavia, a maioria dos terapeutas às vezes não está cien-

te dos próprios sentimentos. É aí que o co-terapeuta pode ser útil. Um co-terapeuta, com frequência, é capaz de reconhecer sentimentos reativos em um colega. Um forte investimento na relação de co-terapia (ou na equipe de tratamento) ajuda a evitar que o terapeuta seja *induzido* (atraído para dentro da família). O terapeuta que atende famílias sem um co-terapeuta deve buscar supervisão, a fim de ter a objetividade necessária para permanecer em equilíbrio.

As primeiras sessões de Whitaker (Napier e Whitaker, 1978) eram bastante estruturadas e incluíam colher a história da família. Para ele, os contatos iniciais com a família eram salvos de abertura na “batalha por estrutura” (Whitaker e Keith, 1981). Ele queria que a família soubesse que os terapeutas é que estavam no comando.² Isso já começava no primeiro telefonema. Whitaker (1976b) insistia no comparecimento do máximo possível de membros da família; acreditava que três gerações eram necessárias para garantir que os avós apoiassem, em vez de solapar, a terapia, e que a presença deles ajudaria a corrigir distorções. Se membros significativos da família não quisessem participar, Whitaker geralmente se recusava a atender a família. Por que começar com as cartas marcadas contra você?

Juntamente com Virginia Satir, Whitaker estava entre os primeiros expoentes do uso de si mesmo como um catalisador de mudanças, mas, enquanto Satir era uma presença calorosa e apoiadora, Whitaker às vezes era brusco, até confrontacional. Na verdade, as intervenções provocativas de alguém como Whitaker só se tornavam aceitáveis para as famílias depois que o terapeuta provava ser uma pessoa compreensiva e interessada. Diante de pessoas desafiadoras, primeiro é preciso conquistar sua confiança.

Quer sejam provocativos, quer apoiadores, os terapeutas experienciais habitualmente são muito ativos. Em vez de deixar que os membros da família resolvam suas questões uns com os outros, o terapeuta fala “Diga a ele (ou a ela) o que você sente!” ou pergunta “O que você está sentindo neste momento?” Assim como a melhor maneira de atrair a atenção da professora na escola é se comportar mal, a melhor maneira de atrair a atenção de um terapeuta experiencial é demonstrar sinais de emoção sem realmente expressá-la.

Estudo de caso

- Terapeuta:* Eu vejo que você olha para o seu pai sempre que faz uma pergunta à sua mãe, o que significa isso?
- Kendra:* Oh, nada...
- Terapeuta:* Isso deve significar *alguma coisa*. Vamos lá, o que você estava sentindo?
- Kendra:* Nada!
- Terapeuta:* Você deve ter sentido alguma coisa. O que foi?
- Kendra:* Bem, às vezes, quando a mamãe me deixa fazer uma coisa, o papai fica furioso. Mas, em vez de gritar com ela, ele grita *comigo* (chorando baixinho).
- Terapeuta:* Diga a ele.
- Kendra:* (Zangada, para a terapeuta) Deixe-me em paz!
- Terapeuta:* Não, isso é importante. Diga ao seu pai como você se sente.
- Kendra:* (Soluçando forte) Você está sempre me repreendendo! Você nunca me deixa fazer nada!

Os terapeutas experienciais empregam várias técnicas expressivas em seu trabalho, incluindo escultura familiar (Duhl, Kantor e Duhl, 1973), entrevistas com uma família de marionetes (Irwin e Malloy, 1975), arte terapia familiar (Geddes e Medway, 1977), desenhos familiares conjuntos (Bing, 1970) e técnicas de terapia gestáltica (Kempler, 1973). Entre os equipamentos do consultório do terapeuta

experiencial estão brinquedos, casas de bonecas, argila, ursinhos de pelúcia, lápis de desenho e papel, e bastões de cera.

Na **escultura familiar**, o terapeuta pede a um membro da família que arrume os outros em um quadro vivo. Este é um meio gráfico de retratar a percepção que cada pessoa tem da família e de seu lugar nela. Era um expediente favorito de Virginia Satir, que costumava usar cordas e vendas nos olhos para dramatizar os papéis limitantes nos quais os familiares apriam-se mutuamente (Satir e Baldwin, 1983).

O seguinte exemplo de escultura ocorreu quando o terapeuta pediu ao Sr. N. que arrumasse os membros da família em uma cena típica do momento em que ele chega em casa do trabalho.

Estudo de caso

- Sr. N.:* Quando eu chego em casa do trabalho, é? Tudo bem (para a mulher), querida, você estaria junto ao fogão, não é?
- Terapeuta:* Não, não fale. Só mova as pessoas e as coloque onde você quer que elas fiquem.
- Sr. N.:* OK.

Ele guiou a esposa até um lugar onde estaria o fogão e colocou os filhos no chão da cozinha, desenhando e brincando.

- Terapeuta:* Ótimo, agora, ainda sem nenhum diálogo, coloque-os em ação.



Os terapeutas experienciais usam técnicas expressivas para ajudar as famílias a chegar aos seus sentimentos subjacentes.

O Sr. N. instruiu a mulher a fingir cozinhar, mas a se virar com frequência para ver o que as crianças estavam aprontando. Ele disse às crianças que fingissem brincar por um momento, mas depois começassem a brigar e a se queixar para a mãe.

Terapeuta: E o que acontece quando você chega em casa?

Sr. N.: Nada. Eu tento conversar com a minha mulher, mas as crianças a importunam tanto que ela fica furiosa e pede para que todos a deixem em paz.

Terapeuta: OK, encenem isso.

A Sra. N. fingiu tentar cozinhar e servir de árbitro nas brigas das crianças. As crianças, que achavam divertidíssimo aquele jogo, fingiram brigar e tentaram superar-se mutuamente para conseguir a atenção da mãe. Quando o Sr. N. “chegou em casa”, ele se aproximou da mulher, mas os filhos se meteram entre os dois, até a Sra. N. finalmente mandar todo o mundo embora.

Mais tarde, a Sra. N. disse que não percebera que o marido se sentia ignorado. Ela só pensava nele como chegando do trabalho, dizendo “oi” e depois se retirando para o seu gabinete com o jornal e uma garrafa de cerveja.

A escultura familiar também é usada para esclarecer cenas do passado. Uma instrução típica é: “Imagine que você está parado diante da casa de sua infância. Entre nela e descreva o que costumava acontecer”. A idéia é fazer um quadro vivo que retrate a percepção da pessoa da vida familiar. É um estratagema para focar a consciência e aumentar a sensibilidade.

Outro exercício expressivo é a *arte terapia familiar*. Kwiatkowska (1976) instrui a família a produzir uma série de desenhos, inclusive um “rabisco familiar conjunto”, em que cada pessoa faz um rabisco rápido e depois a família toda incorpora o rabisco em um desenho unificado. Elizabeth Bing (1970) descreve o **desenho familiar** conjunto como um meio de preparar a família e desembaraçá-la para se expressar. Nesse procedimento, é dito à família: “Façam um desenho de como vocês se vêem como família”. Os retratos resultantes podem revelar percepções ainda não discutidas ou estimular a pessoa que fez o desenho a se dar conta de algo em que jamais pensara antes.

Nas *entrevistas com famílias de marionetes*, Irwin e Malloy (1975) pedem a um dos familiares que crie uma história usando marionetes. Esta técnica, originalmente usada na

Estudo de caso

Um pai fez um desenho da família que o mostrava separado, do lado, enquanto sua mulher e seus filhos estavam de mãos dadas. Embora ele estivesse desenhando um fato bem conhecido por ele e pela esposa, eles nunca haviam falado abertamente sobre isso. Quando ele mostrou o desenho para o terapeuta, não houve como evitar a discussão. Em outro caso, quando o terapeuta pediu a cada membro da família que fizesse o desenho, a filha adolescente não sabia o que fazer. Ela nunca pensara muito sobre a família ou o seu papel nela. Quando começou a desenhar, a imagem simplesmente pareceu emergir. Ela ficou surpresa ao descobrir que havia se desenhado mais perto do pai e das irmãs do que da mãe. Isso provocou uma discussão animada entre ela e a mãe sobre o seu relacionamento. Embora as duas parecessem passar bastante tempo juntas, a filha não se sentia próxima porque achava que a mãe a tratava como criança, jamais conversando com ela sobre as próprias preocupações e demonstrando um interesse apenas superficial pela vida da filha. Por sua parte, a mãe ficou surpresa, e bastante satisfeita, ao ver que a filha se sentia pronta para estabelecer um relacionamento mais mútuo e carinhoso.

ludoterapia, visa a salientar conflitos e alianças. De fato, sua utilidade provavelmente se limita ao trabalho com crianças. A maioria dos adultos reluta em expressar algo pessoal por um meio tão infantil. Até uma criança de 8 anos sabe o que está acontecendo quando o terapeuta diz “Conte-me uma história”.

O **desempenho de papel** é outro expediente muito apreciado. Seu uso baseia-se na premissa de que a experiência, para ser real, precisa ser trazida à vida no presente. A lembrança de acontecimentos passados e a consideração de eventos futuros esperados ou temidos podem ser tornadas mais imediatas dramatizando-se a situação na imediação da sessão. Kempler (1968) encorajava os pais a fantasiarem e dramatizarem cenas da infância. Uma mãe poderia ser solicitada a dramatizar o que acontecia quando ela era garotinha, ou um pai poderia se imaginar como um menino aprisionado no mesmo dilema do filho.

Quando alguém ausente é mencionado, o terapeuta pode introduzir a *técnica da cadeira vazia*, da Gestalt (Kempler, 1973). Se uma criança fala sobre seu avô, podemos pedir a ela que fale com uma cadeira que personifica o avô. Whitaker (1975) empregava uma técnica

ca semelhante de desempenho de papel, que ele chamava de “psicoterapia do absurdo”. Isso consiste em exagerar a qualidade insensata da resposta de um paciente até o ponto do absurdo. Em geral é como tirar a máscara de alguém, conforme o seguinte exemplo ilustra:

Paciente: Eu não suporto o meu marido!
Terapeuta: Por que você não se livra dele ou arranja um namorado?

Às vezes, isso assume a forma de uma troca sarcástica, como imitar exageradamente em resposta a uma criança importuna. A esperança é que o paciente adquira uma distância objetiva ao participar do distanciamento do terapeuta; o perigo é que ele se sinta magoado por ter sido objeto de zombaria.

Essas técnicas se mostraram úteis na terapia individual (Nichols e Zax, 1977) para intensificar a experiência emocional ao focalizar lembranças e atuar reações reprimidas. É ainda questionável se esses expedientes são necessários na terapia familiar. No tratamento individual, os pacientes estão isolados das figuras significativas de sua vida, e a dramatização pode ser útil para aproximar o estar com essas pessoas. No entanto, como a terapia familiar é realizada com as pessoas significativas presentes, parece duvidoso que o desempenho de papel ou outros meios de fantasia sejam necessários. Se o que queremos é ação emocional, isso é o que não falta: basta abrir o diálogo entre os membros da família.



Duas abordagens emotivas recentes à terapia familiar, que representam um entendimento mais sofisticado da dinâmica familiar, são a terapia de casal com foco na emoção e o modelo sistêmico familiar interno.

Terapia de casal focada na emoção

A terapia de casal focada na emoção funciona em dois níveis sucessivos – descobrir a mágoa e o anseio que estão por trás de expressões defensivas de raiva e retraimento e depois ajudar o casal a compreender como esses sentimentos agem em seu relacionamento. Para

começar, o terapeuta reconhece os sentimentos imediatos de cada cliente – mágoa e raiva, digamos – para que se sintam compreendidos (Johnson, 1998).

Estudo de caso

“Você está ficando cada vez mais zangada. Incomoda você ouvir o Will retratar-se como inocente, não é?”

Ao interromper uma briga do casal e refletir sobre o que cada um está sentindo, a terapeuta desarma a hostilidade e os ajuda a se concentrarem em sua experiência, e não nos crimes um do outro. Então, para explorar as percepções que estão por trás das reações emocionais do parceiro, a terapeuta pede uma descrição do que acontece em casa.

“Oh, então uma parte de você acredita nele, mas outra parte desconfia?”

“Uma parte de você está observando e esperando que ele a magoe?”

“Você pode me falar sobre a parte que acredita que ele está sendo honesto?”

A seguir, a terapeuta aponta como as emoções do casal os levam a ciclos de polarização cada vez mais intensa.

O ciclo foi assim formulado: Will se protege ficando distante e evitando a raiva de Nancy; ela, ficando vigilante e tentando evitar ser traída novamente. Quanto mais insegura e desconfiada ela fica, mais Will se sente impotente e se distancia. Quanto mais ele se distancia, mais ela se sente traída e mais raivosa fica. Ambos foram enquadrados como vítimas do ciclo, que eu continuamente formulei como um problema comum com o qual os parceiros precisam se ajudar. (Johnson, 1998, p. 457-458)

A crescente consciência do casal de como sua reatividade emocional frustra seus anseios monta o cenário para descobrir e expressar as emoções profundas que estão por trás de suas brigas. A expressão catártica resultante pos-



O foco de Susan Johnson nos anseios emocionais pode ser visto como um antídoto para a atual preocupação do campo com a cognição.

sibilita que o casal aprofunde o entendimento do seu padrão destrutivo mútuo, e este processo circular continua a ser explorado no processo da elaboração.

A teoria do apego ajuda o terapeuta de casal emocionalmente focado a identificar as questões que são remexidas quando o casal fala sobre suas mágoas e sobre seus anseios.

“Talvez você se sinta como se ninguém a amasse realmente.”

“Você se sente impotente e sozinho, não é?”

O impacto dessa evocação emocional é intensificado pelo fato de que o parceiro está presente para ser tratado desta maneira nova e mais “cheia de sentimentos”.

“Então, você pode dizer isso a ela?”

O objetivo fundamental deste trabalho é fazer com que os parceiros se arrisquem a ficar vulneráveis um para o outro, ao reconhecer e expressar suas necessidades de apego.

“Só você pode enfrentar seu medo e decidir se arriscar a confiar no Will. Ele não pode fazer isso, pode? A única pessoa que pode abandonar as suas defesas e se arriscar a confiar nele é você, não é?”

“Qual é a pior coisa que poderia acontecer?”

Novamente, trabalhar junto com o casal significa que, quando um dos parceiros se arrisca a expressar suas necessidades e seus medos, o outro pode ser encorajado a responder.

“O que acontece com você, Will, quando escuta isso?”

A resposta a essa pergunta, evidentemente, será muito diferente depois que os parceiros baixarem a guarda e começarem a conversar sobre o que temem e o que realmente querem um do outro.

O terapeuta de casal emocionalmente focado enquadra as experiências dos membros da família em termos de privação, isolamento e perda de conexão segura. Esta perspectiva, da teoria do apego, ajuda os familiares a focalizarem seus anseios, e não os defeitos e falhas. O processo da intervenção terapêutica foi descrito em nove etapas de tratamento (Johnson, Hunsley, Greenberg e Schindler, 1999):

1. Avaliar – criar uma aliança e explicar as questões centrais do conflito do casal utilizando a teoria do apego
2. Identificar o ciclo de interação problemático que mantém a insegurança do apego e o sofrimento no relacionamento

3. Descobrir as emoções não-reconhecidas que estão por trás das posições interacionais
4. Reenquadrar o problema em termos de um ciclo problemático com emoções e necessidades de apego subjacentes
5. Encorajar a aceitação e a expressão de necessidades e aspectos do *self* não-assumidos
6. Encorajar a aceitação da nova abertura do parceiro
7. Incentivar a expressão de necessidades e desejos específicos e criar um engajamento íntimo, emocional
8. Facilitar novas soluções para questões não-resolvidas do relacionamento
9. Consolidar novas posições e a expressão mais honesta das necessidades de apego

Em todos estes passos, o terapeuta se alterna entre ajudar os parceiros a descobrir e expressar sua experiência emocional e ajudá-los a reorganizar o padrão de suas interações. Por exemplo:

O terapeuta poderia, então, ajudar primeiro o cônjuge distanciado, reservado, a formular o sentimento de impotência paralisada que alimenta seu distanciamento. O terapeuta validará este sentimento de impotência ao colocá-lo no contexto do ciclo destrutivo que domina o relacionamento. O terapeuta vai salientar essa experiência na sessão e depois ajudar a parceira a escutá-la e a aceitá-la, mesmo que isso seja muito diferente da maneira pela qual ela habitualmente experienciava o marido. Por fim, o terapeuta passa a estruturar uma interação em torno dessa impotência, como: “Agora você pode se virar para ela e dizer ‘Eu me sinto tão impotente e derrotado. Eu só tenho vontade de fugir e me esconder’”. Este tipo de afirmação, em e por si mesma, representa um afastamento do distanciamento passivo e é o começo de um engajamento emocional ativo. (Johnson, Hunsley, Greenberg e Schindler, p. 70)

Terapia familiar sistêmica interna

No modelo familiar sistêmico interno (Schwartz, 1995), vozes internas conflitantes são personificadas como subpersonalidades ou “partes”. O que torna este um esquema tão forte é que, embora com frequência haja desaven-

ças entre os familiares do cliente, seus conflitos muitas vezes baseiam-se em polarizações de parte do que eles sentem. A verdade é que as pessoas em conflito umas com as outras geralmente também estão em conflito consigo mesmas.

O desafio da adolescente e a desconfiança dos pais são apenas um aspecto dos complexos sentimentos que eles nutrem um pelos outros. Escolhendo um exemplo diferente, o casal aprisionado em um padrão perseguidor-distanciador pode atuar apenas nos papéis que morrem de medo de abandono e engolfamento. Ao dramatizar os elementos de seus conflitos internos, a terapia sistêmica familiar interna ajuda os membros da família a identificarem seus sentimentos e se reconectarem de maneira menos polarizada.

Para ajudar os clientes a distinguir entre suas vozes interiores conflitantes, Schwartz começa introduzindo a linguagem das partes.

Estudo de caso

“Então, existe uma parte sua que fica chateada e zangada quando seu filho se deprime e se desvaloriza. Você acha que, se essa parte não fosse tão sensível, seria mais fácil para você ajudá-lo?”

“Parece que uma parte sua concorda com o seu marido em relação a ser mais rígida com as crianças, mas há outra parte que diz que ele é duro demais. Que segunda parte é essa? O que ela lhe diz? Do que ela tem medo?”

Ao escutar atentamente o que os clientes estão sentindo e, então, construir suas reações como oriundas de uma parte deles, o terapeuta inicia uma mudança nas polarizações familiares. É mais fácil para as pessoas reconhecer que “uma parte delas” sente – raiva, impotência, ou qualquer outra coisa – que reconhecer que “elas” (no sentido integral) têm determinado sentimento. O pai que possui dificuldade de admitir que está com raiva do filho por não ir bem na escola talvez ache mais fácil reconhecer que uma parte dele fica zangada com os fracassos do filho – e, além disso, que a parte zangada atrapalha sua parte compreensiva.

Depois de introduzir a idéia de que várias partes dos familiares reagem aos outros, em vez de verem a si mesmos como se tivessem desavenças intrínsecas, eles podem começar a ver quais partes de um acionam partes de outro. A implicação óbvia é que, se as emoções agravantes estão contidas apenas em partes deles, também existem outros sentimentos e outras possibilidades de interação.

Assim: “Então, essa parte zangada do seu pai parece acionar uma parte triste e impotente em você, não é?”

Como muitas dessas polarizações se tornam triângulos, pode ser que a parte zangada do pai também acione uma parte protetora em sua mulher.

“Então, quando você vê a parte zangada do seu marido reagir ao seu filho, isso desencadeia uma parte protetora em você? Uma parte sua sente que você precisa brigar com seu marido para proteger seu filho?”

Dessa forma, em vez de ter um filho que é um fracasso, um pai que não compreende e pais que não concordam, a família descobre que cada um deles tem dificuldade em alguns aspectos. O pai é transformado, passa de um tirano a um pai que enfrenta uma parte de frustração e zanga. Sua mulher deixa de estar basicamente em oposição a ele e, em vez disso, é vista como se tivesse uma parte protetora que é acionada pela parte zangada dele. Em vez de ser um fracasso, o filho se torna um menino com uma parte que se sente impotente diante da parte zangada do pai e do conflito dos pais.

Como todos os modelos experienciais, a terapia familiar sistêmica interna se fundamenta na crença de que, por trás das partes emocionalmente reativas das pessoas, existe um *self* sadio no âmago da personalidade. Quando o terapeuta percebe várias partes que estão assumindo o controle, ele, primeiro, pede à pessoa que as visualize e, depois, ajuda a acalmá-las. Se, por exemplo, uma parte zangada foi vista como um cachorro que rosna, essa pessoa poderia descobrir ser capaz de acalmar sua raiva aproximando-se do cachorro e afagando-o até ele se acalmar e se acomodar. Para usar outro exemplo (citado por Schwartz, 1998), se uma parte assustada fosse imaginada como uma boneca de pano, a pessoa poderia aliviar seu medo ao se visualizar pegando a boneca no colo e confortando-a. Assim, ao personificar as reações emocionais polarizadoras como partes e, depois, ao ajudar as pessoas a visualizar e tranquilizar essas partes reativas, a terapia sistêmica familiar interna liberta as pessoas da dominação do medo e da raiva, o que, por sua vez, permite que trabalhem juntas mais efetivamente a fim de resolver problemas pessoais e familiares.

AVALIANDO A TEORIA E OS RESULTADOS DA TERAPIA

A terapia experiencial ajuda os membros da família a irem além da superfície de suas

interações e explorarem os sentimentos que as impelem. Do melhor modo, esta abordagem ajuda as pessoas a abandonarem suas defesas e conviverem com maior imediação e autenticidade. Dada a ênfase da terapia familiar no comportamento e na cognição, o esforço para ajudar os clientes a descobrirem o lado sentimental de sua experiência é, com certeza, uma adição bem-vinda.

Independentemente da abordagem de terapia familiar escolhida, focalizar os indivíduos e sua experiência é uma boa maneira de romper discussões defensivas. Quando os membros da família brigam, habitualmente avançam com suas defesas. Em vez de dizerem “*Eu estou magoado*”, dizem “*Você me magoou*”; em vez de admitir que estão com medo, criticam o comportamento alheio. Uma maneira efetiva de romper esta escalada contenciosa improdutiva é explorar o afeto dos participantes, um de cada vez. Ao conversarem sobre o que cada um está sentindo – e as raízes de tais sentimentos –, os familiares podem ser ajudados a ir além da defensividade que os mantém separados e a reconectar-se em um nível mais genuíno.

Todavia, exatamente como as abordagens que se concentram de todo nas famílias e em suas interações deixam algo de fora, o mesmo acontece nas abordagens que se concentram de forma excessivamente limitada nos indivíduos e em sua experiência emocional. No pico da sua popularidade, nos anos de 1970, os terapeutas experienciais tratavam a terapia familiar como se fosse um grupo de encontro para parentes. Tinham uma imensa fé no valor da experiência emocional individual e uma limitada apreciação do papel que a estrutura familiar desempenha na regulação dessa experiência. Não surpreendentemente, portanto, conforme a terapia familiar passou a focar mais a organização, a interação e a narrativa nas décadas de 1980 e 1990, o modelo experiencial perdeu o prestígio.

Como já sugerimos, uma terapia planejada principalmente para eliciar sentimentos pode ser mais adequada a grupos de encontro do que à terapia familiar. Entretanto, os modelos comportamentais e cognitivos prevalentes de terapia familiar bem poderiam dar maior atenção aos sentimentos das pessoas. Se “maior atenção aos sentimentos das pessoas” soa um tanto vago, permita-nos tornar isso mais con-

creto. Ajudar os membros da família a entrarem em contato com seus sentimentos faz com que duas coisas aconteçam: ajuda-os, como indivíduos, a descobrirem o que realmente pensam e sentem – o que querem e do que têm medo – e os ajuda, como família, a irem além da defensividade e comecem a se relacionar entre si de maneira mais honesta e imediata.

Duas abordagens particularmente criativas para ajudar as pessoas a entrarem em contato com a sua experiência interna são a terapia de casal com foco emocional e a terapia familiar sistêmica interna. O que separa a terapia de Johnson e Greenberg é a sua combinação de expressividade emocional e atenção à dinâmica das interações entre o casal. A terapia de casal focada na emoção começa, como todas as abordagens emotivas, eliciando e reconhecendo os sentimentos com os quais os clientes chegam – mesmo, ou especialmente, se esses sentimentos forem defensivos. Não chegaremos ao que está por trás dos sentimentos das pessoas se ignorarmos esses sentimentos.

Descobrir emoções mais profundas, mais vulneráveis, e reconhecer os padrões reativos criados por seus sentimentos cria para o casal uma experiência cognitiva significativa. Conforme Lieberman, Yalom e Miles (1973) demonstraram com grupos de encontros, uma experiência terapêutica emocionalmente intensa só tem valor duradouro quando acompanhada por um entendimento intelectual da importância dessas emoções. O único alerta que poderíamos oferecer é que as explicações são mais proveitosas após um processo emocionalmente significativo de descobrimento – isso distingue a psicoterapia de uma conversa com a sua tia Rose.

A abordagem familiar sistêmica interna de Schwartz ajuda os membros da família a conviverem com maior entendimento ao ajudá-los a identificar a própria experiência conflituosa. Personificar emoções ingovernáveis como “partes” é uma maneira poderosa de ajudar as pessoas a obterem uma distância esclarecedora de seus conflitos. Distinta da terapia emocionalmente focada, a terapia familiar sistêmica interna não se baseia em suma em explicações didáticas. Nesta abordagem, a experiência emocional é esclarecida, mas aprendendo-se a diferenciar os próprios sentimentos, em vez de usar explicações oferecidas pelo terapeuta.

Além de relatos informais de resultados bem-sucedidos (Napier e Whitaker, 1978; Duhl e Duhl, 1981) e descrições de técnicas que são efetivas para catalisar a expressão emocional dentro da sessão (Kempler, 1981), a terapia de casal emocionalmente focada também tem recebido confirmação empírica (por exemplo, Johnson e Greenberg, 1985, 1988; Johnson, Maddeaux e Blouin, 1998; Johnson, Hunsley, Greenberg e Schindler, 1999).

Recentemente, pesquisadores que estudam a efetividade das técnicas experienciais seguiram a sugestão de Mahrer (1982) de focar o processo, em vez do resultado, da terapia. Como ele acreditava que os estudos de resultado têm pouco impacto sobre os profissionais (que já “sabem” que o que fazem funciona), Mahrer recomendou que se estudasse o “resultado dentro da terapia” – isto é, quais tipos de intervenção produzem os resultados desejados (expressão emocional, comunicação mais aberta) dentro das sessões. Seguindo Mahrer (1982) e outros (Pierce, Nichols e DuBrin, 1983) que examinaram esses resultados na terapia no tratamento individual, Leslie Greenberg e Susan Johnson descobriram que ajudar um parceiro zangado e agressivo a revelar seus sentimentos mais ternos caracteriza a melhor sessão dos casos bem-sucedidos (Johnson e Greenberg, 1988) e que a auto-revelação íntima leva a sessões mais produtivas (Greenberg, Ford, Alden e Johnson, 1993).

Outrora, o sentimento e a expressão ocupavam o palco central nas terapias psicológicas; hoje, este lugar é ocupado pelo comportamento e pela cognição. Os psicoterapeutas descobriram que as pessoas pensam e agem, mas isso não significa que devemos ignorar a experiência emocional imediata, que é a principal preocupação da terapia familiar experiencial.

RESUMO

A terapia experiencial trabalha do interior para o exterior – fortalecendo as famílias ao encorajar a auto-expressão individual, revertendo a direção habitual do efeito na terapia familiar. A terapia familiar experiencial também se distingue por um comprometimento com o bem-estar emocional, em oposição à solução dos problemas. A integridade pessoal e a auto-

realização são vistas como capacidades humanas inatas que surgirão espontaneamente depois que a defensividade for superada. Para desafiar o familiar e intensificar a experiência, o terapeuta utiliza sua personalidade vívida, além de uma série de técnicas expressivas.

Embora o modelo experiencial tenha perdido popularidade na década de 1980, ele está de certa forma ressurgindo, em especial no trabalho inovador da terapia de casal com foco emocional e na abordagem familiar sistêmica interna. Outrora, a idéia de que as famílias eram sistemas era tanto nova quanto controversa; atualmente, ela é a nova ortodoxia. Agora que o pêndulo andou tanto na direção do pensamento sistêmico, os indivíduos e suas alegrias e dores particulares raramente são mencionados. Com certeza, uma das maiores contribuições da terapia familiar experiencial é nos lembrar de que não devemos perder de vista o *self* no sistema.

NOTAS

1. Embora, em certo momento, a família tenha sido retratada como o inimigo da liberdade e da autenticidade (Laing e Esterson, 1970).
2. Poderíamos acrescentar que existe uma grande diferença entre tentar controlar a estrutura das sessões e tentar controlar a vida das pessoas.

LEITURAS RECOMENDADAS

- Duhl, B. S., e Duhl, F. J. 1981. Integrative family therapy. In *Handbook of family therapy*, A. S. Gurman e D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/Mazel.
- Duhl, F.J., Kantor, D., e Duhl, B. S. 1973. Learning, space and action in family therapy: A primer of sculpture. In *Techniques in family therapy*, D. A. Bloch, ed. New York: Grune & Stratton.
- Greenberg, L. S., e Johnson, S. M. 1988. *Emotionally focused therapy for couples*. New York: Guilford Press.
- Keith, D. V., e Whitaker, C. A. 1977. The divorce labyrinth. In *Family therapy: Full-length case studies*, P. Papp, ed. New York: Gardner Press.
- Laing, R. D., e Esterson, A. 1970. *Sanity, madness and the family*. Baltimore: Penguin Books.
- Napier, A. Y., e Whitaker, C. A. 1978. *The family crucible*. New York: Harper & Row.

- Neill, J. R., e Kniskern, D. P., eds. 1982. *From psyche to system: The evolving therapy of Carl Whitaker*. New York: Guilford Press.
- Satir, V. M. 1988. *The new people making*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Satir, V. M., e Baldwin, M. 1983. *Satir step by step: A guide to creating change in families*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Schwartz, R. C. 1995. *Internal family systems therapy*. New York: Guilford Press.
- Schwartz, R. C. 1998. Internal family systems therapy. In *Case studies in couple and family therapy*, F. M. Dattilio ed. New York: Guilford Press.
- Whitaker, C. A., e Bumberry, W. M. 1988. *Dancing with the family: A symbolic experiential approach*. New York: Brunner/Mazel.
- Whitaker, C. A., e Keith, D. V. 1981. Symbolic-experiential family therapy. In *Handbook of family therapy*, A. S. Gurman e D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/Mazel.
- Andreas, S. 1991. *Virginia Satir: The patterns of her magic*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Bing, E. 1970. The conjoint family drawing. *Family Process*. 9, p. 173-194.
- Binswanger, L. 1967. Being-in-the-world. In *Selected papers of Ludwig Binswanger*, J. Needleman, ed. New York: Harper Torchbooks.
- Boss, M. 1963. *Psychoanalysis and daseinanalysts*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. 1969. *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. 1988. *A secure base*. New York: Basic Books.
- Collins, N. L., e Read, S. J. 1994. Cognitive representations of attachment: The structure and function of working models. In *Attachment processes in adulthood*, K. Bartholomew e D. Perlman, eds. London: Jessica Kingsley.
- Duhl, B. S., e Duhl, F. J. 1981. Integrative family therapy. In *Handbook of family therapy*, A. S. Gurman e D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/Mazel.
- Duhl, F. J., Kantor D., e Duhl, B. S. 1973. Learning, space and action in family therapy: A primer of sculpture. In *Techniques of family psychotherapy*, D. A. Bloch, ed. New York: Grune & Stratton.
- Geddes, M., e Medway, J. 1977. The symbolic drawing of family life space. *Family Process*. 16, p. 219-228.
- Gehrke, S., e Kirschenbaum, M. 1967. Survival patterns in conjoint family therapy. *Family Process*. 6, p. 67-80.
- Greenberg, L. S., Ford, C. L., Alden, L., e Johnson, S. M. 1993. In-session change in emotionally focused therapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 61, p. 78-84.
- Greenberg, L. S., e Johnson, S. M. 1985. Emotionally focused couple therapy: An affective systemic approach. In *Handbook of family and marital therapy*, N. S. Jacobson e A. S. Gurman, eds. New York: Guilford Press.
- Greenberg, L. S., e Johnson, S. M. 1986. Affect in marital therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*. 12, p. 1-10.
- Greenberg, L. S., e Johnson, S. M. 1988. *Emotionally focused therapy for couples*. New York: Guilford Press.
- Irwin, E., e Malloy, E. 1975. Family puppet interview. *Family Process*. 14, p. 179-191.
- Johnson, S. M. 1998. Emotionally focused couple therapy. In *Case studies in couple and family therapy*, F. M. Dattilio, ed. New York: Guilford Press.
- Johnson, S. M., e Greenberg, L. S. 1985. Emotionally focused couples therapy: An outcome study. *Journal of Marital and Family Therapy*. 11, p. 313-317.
- Johnson, S. M., e Greenberg, L. S. 1988. Relating process to outcome in marital therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*. 14, p. 175-183.
- Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L., e Schindler, D. 1999. Emotionally focused couples therapy: Status and challenges. *Clinical Psychology: Science and Practice*. 6, p. 67-79.
- Johnson, S. M., Maddeaux, C., e Blouin, J. 1998. Emotionally focused therapy for bulimia: Changing attachment patterns. *Psychotherapy*. 35, p. 238-247.
- Kaplan, M. L., e Kaplan, N. R. 1978. Individual and family growth: A Gestalt approach. *Family Process*. 17, p. 195-205.
- Kempler, W. 1968. Experiential psychotherapy with families. *Family Process*. 7, p. 88-89.
- Kempler, W. 1973. *Principles of Gestalt family therapy*. Oslo: Nordahls.
- Kempler, W. 1981. *Experiential psychotherapy with families*. New York: Brunner/Mazel.
- Kwiatkowska, H. Y. 1967. Family art therapy. *Family Process*. 6, p. 37-55.
- Laing, R. D. 1967. *The politics of experience*. New York: Ballantine.
- Laing, R. D., e Esterson, A. 1970. *Sanity, madness and the family*. Baltimore, MD: Penguin Books.
- Lieberman, M.A., Yalom, I.D., e Miles, M.B. 1973. *Encounter groups: First facts*. New York: Basic Books.

REFERÊNCIAS

- Mahrer, A. R. 1982. *Experiential psychotherapy: Basic practices*. New York: Brunner/Mazel.
- Malone, T., Whitaker, C. A., Warkentin, J., e Felder, R. 1961. Rational and nonrational psychotherapy. *American Journal of Psychotherapy*. 15, p. 21- 220.
- Marcuse, H. 1955. *Eros and civilization*. New York: Beacon Press.
- Napier, A. Y. 1977. Follow-up to divorce labyrinth, In *Family therapy: Full-length case studies*, P Papp, ed. New York: Gardner Press.
- Napier, A. Y., e Whitaker, C. A. 1978. *The family crucible*. New York: Harper & Row.
- Nichols, M. P., e Zax, M. 1977. *Catharsis in psychotherapy*. New York: Gardner Press.
- Pierce, R., Nichols, M. P., e DuBrin, J. 1983. *Emotional expression in psychotherapy*. New York: Gardner Press.
- Rogers, C. R. 1951. *Client-centered therapy*. Boston: Houghton Mifflin.
- Satir, V. M. 1964. *Conjoint family therapy*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Satir, V. M. 1972. *Peoplemaking*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Satir, V. M., e Baldwin, M. 1983. *Satir step by step: A guide to creating change in families*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- Schwartz, R. C. 1995. *Internal family systems therapy*. New York: Guilford Press.
- Schwartz, R. C. 1998. Internal family systems therapy. In *Case studies in couple and family therapy*, F. M. Dattilio, ed. New York: Guilford Press.
- Simon, R. 1989. Reaching out to life: An interview with Virginia Satir. *The Family Therapy Networker*: 13(1), p. 36-43.
- Sullivan, H. S. 1953. *The interpersonal theory of psychiatry*. New York: Norton.
- Whitaker, C. A. 1958. Psychotherapy with couples. *American Journal of Psychotherapy*. 12, p. 18-23.
- Whitaker, C. A. 1967. The growing edge. In *Techniques of family therapy*, J. Haley e L. Hoffman, eds. New York: Basic Books.
- Whitaker, C. A. 1975. Psychotherapy of the absurd: With a special emphasis on the psychotherapy of aggression. *Family Process*. 14, p. 1-16.
- Whitaker, C. A. 1976a. The hindrance of theory in clinical work. In *Family therapy: Theory and practice*, P. J. Guerin, ed. New York: Gardner Press.
- Whitaker, C. A. 1976b. A family is a four-dimensional relationship. In *Family therapy: Theory and practice*, P. J. Guerin, ed. New York: Gardner Press.
- Whitaker, C. A., e Keith, D. V. 1981. Symbolic-experiential family therapy. In *Handbook of family therapy*, A. S. Gurman and D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/Mazel.
- Whitaker, C. A., e Malone, T. P. 1953. *The roots of psychotherapy*. New York: Blakiston.
- Whitaker, C. A., Warkentin, J., e Malone, T. P. 1959. The involvement of the professional therapist. In *Case studies in counseling and psychotherapy*, A. Burton, ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.